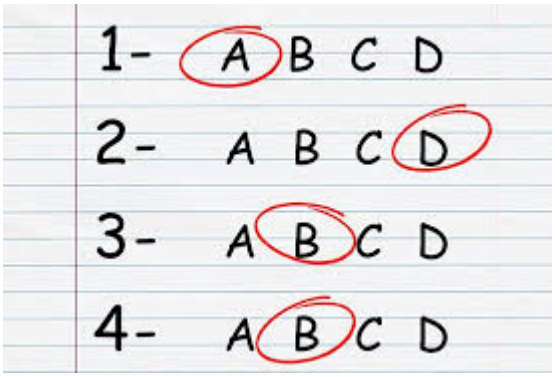


TEMA 50



TEST

DEL

TEMA

LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS ADICCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD.

1.- ¿En qué año abre el Ayuntamiento de Madrid el primer dispositivo de atención a las drogodependencias?:

a.- En 1.977.

b.- En 1.982.

c.- En 1.987.

2.- El Ayuntamiento de Madrid aprueba el primer Plan Municipal contra las Drogas:

a.- En 1.980.

b.- En 1.983.

c.- En 1.988.

3.- El quinquenio 1.996-2.000 se va a caracterizar:

a.- Porque se ponen en marcha los programas de prevención.

b.- Porque se ponen en marcha los programas de sustitutivos de opiáceos.

c.- Ambas opciones son correctas.

4.- Madrid Salud no tiene como finalidad la gestión de las políticas municipales en materia de:

a.- Salud Pública.

b.- Drogodependencias y otros trastornos adictivos.

c.- Prevención de las discapacidades.

5.- El primer nivel de atención en materia de drogodependencias se caracteriza por:

a.- La atención ambulatoria.

b.- La atención en proximidad.

c.- La atención comunitaria.

6.- El primer nivel de atención en materia de drogodependencias:

a.- Tiene como objetivo principal la detección y captación de personas con adicciones.

b.- Interviene con personas que no acceden a los centros de tratamiento ambulatorio.

c.- Ambas opciones son correctas.

7.- En el primer nivel las intervenciones se van a centrar:

a.- En los procesos de deshabituación.

b.- En los procesos de inserción socio laboral.

c.- En la reducción de daños.

8.- Dentro del primer nivel de atención vamos a encontrar:

a.- Unidad Móvil de Reducción del Daño Madroño.

b.- Programa de Mediación Comunitaria.

c.- Ambas opciones son correctas.

9.- Se consideran Centros Ambulatorios de segundo nivel:

a.- Centros de Atención a las Adicciones.

b.- Centros Concertados de Atención a las Adicciones.

c.- Ambas opciones son correctas.

10.- Los CAD y los CCAD son centros:

a.- De carácter biopsicosocial.

b.- De carácter psicosocial.

c.- De carácter sociosanitario.

11.- En relación a los recursos en drogodependencias de segundo nivel podemos señalar que (indica la opción incorrecta):

a.- Actúan como el eje de intervención integral de las personas en tratamiento.

b.- Se diseña y coordina el plan de intervención individualizada con cada paciente.

c.- Se interviene desde la perspectiva de reducción de riesgos.

12.- A los recursos de tercer nivel se accede por derivación (señala la opción incorrecta):

a.- De los CAIDs.

b.- De los CADs.

c.- De los CCADs.

13.- Señala la opción incorrecta en relación a los recursos de tercer nivel:

a.- Prestan una atención en áreas específicas, durante un tiempo ilimitado, que no puede ser ofertada desde los recursos de segundo nivel.

b**.-** Mantienen una coordinación permanente con los Centros de Atención a las Adicciones para facilitar la consecución de objetivos terapéuticos.

c.- Derivan de nuevo a los pacientes a los centros de referencia una vez finalizada su intervención.

14.- En relación a los Centros de Atención a las Adicciones:

a.- Hay 7 CADs y 3 CCADs.

b.- Hay 6 CADs y 4 CCADs.

c.- Hay 3 CADs y 7 CCADs.

15.- El Centro de Atención Básica Sociosanitaria:

a.- Es un recurso residencial.

b.- Ofrece alimentación básica, reducción de daños y riesgos, intervenciones sanitarias básicas, acompañamientos ...

c.- Ambas opciones son correctas.

16.- ¿Cuántos Centros Concertados de Atención a las Adicciones hay?:

a.- 1 CCAD.

b.- 2 CCAD.

c.- 3 CCAD.

17.- No es un recurso de apoyo al tratamiento y a la reinserción:

a.- El Centro de Patología Dual.

b.- La Unidad Móvil "Madroño".

c.- El Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información al detenido drogodependiente.

18.- El Programa Istmo está especializado:

a.- En la atención a población drogodependiente muy cronificada.

b.- En la atención a mujeres con problemas de drogodependencias.

c.- Ambas opciones son falsas.

19.- La Unidad Móvil "Madroño":

a.- Previene el desarrollo de enfermedades asociadas a la drogodependencia.

b.- Facilita la captación y derivación a otros recursos.

c.- Ambas opciones son correctas.

20.- Desde la Unidad Móvil "Madroño" se prestan servicios básicos:

a.- De atención sanitaria.

b.- De alimentación y ropa.

c.- Además de las opciones anteriores, de higiene.

21.- Son servicios prestados desde la Unidad Móvil "Madroño":

a.- Orientación formativo-laboral.

b.- Atención psiquiátrica de bajo umbral.

c.- Ambas opciones son falsas.

22.- Desde el Programa Itsmo se ofrece:

a.- Atención a la población inmigrante con adicciones.

b.- Atención a la población sin hogar con adicciones.

c.- Atención a la población femenina con adicciones.

23.- El Programa de Mediación Comunitaria pretende:

a.- Disminuir la conflictividad relacionada con la apertura de centros dirigidos a población drogodependiente.

b.- Disminuir la conflictividad relacionada con la presencia de drogodependientes reunidos en determinadas zonas de la ciudad.

c.- Ambas opciones son correctas.

24.- La Unidad Hospitalaria de desintoxicación en alcohol:

a.- Es un dispositivo de primer nivel.

b.- Uno de sus objetivos es favorecer la motivación para la continuidad del tratamiento de modo ambulatorio.

c.- Ambas opciones son falsas.

25.- El tiempo de estancia aproximado en la Unidad Hospitalaria de desintoxicación en alcohol es:

a.- 7 días.

b.- 14 días.

c.- 21 días.

26.- Los Centros de Día intervienen con:

a.- Población adicta sin alternativas de ocio y tiempo libre.

b.- Población adicta con problemas de aislamiento social y falta de apoyo familiar o red social.

c.- Población adicta con importante deterioro socio-sanitario.

27.- Los Centros de Día ofertan servicios:

a.- Socio-sanitarios.

b.- Formativos, educativos y de ocio.

c.- Ambas opciones son correctas.

28.- El recurso convivencial terapéutico para jóvenes y adolescentes está orientado:

a.- A menores de 25 años.

b.- A menores de 23 años.

c.- A menores de 21 años.

29.- Desde el recurso convivencial para jóvenes y adolescentes:

a.- Se lleva a cabo la desintoxicación de aquellas personas que lo precisen en colaboración con los CAD y los CCAD.

b.- Se realiza un programa personalizado de deshabituación con cada paciente.

c.- Ambas opciones son correctas.

30.- Entre la oferta de Comunidades Terapéuticas vamos a encontrar:

a.- Comunidades Terapéuticas para pacientes con Patología Dual.

b.- Comunidades Terapéuticas para pacientes crónicos y/o con deterioro cognitivo.

c.- Ambas opciones son correctas.

31.- Las Comunidades Terapéuticas ofrecen, entre sus servicios:

a.- Desintoxicación.

b.- Dispensación de metadona y otros fármacos.

c.- Ambas opciones son correctas.

32.- El tiempo de estancia en la Unidad Hospitalaria de Patología Dual:

a.- Es un tiempo mínimo de estancia de 3 semanas y máximo de 3 meses.

b.- Es un tiempo mínimo de estancia de 4 semanas y máximo de 4 meses.

c.- Es un tiempo mínimo de estancia de 6 semanas y máximo de 6 meses.

33.- En la Unidad Hospitalaria de Patología Dual:

a.- Se ofrece un abordaje terapéutico de la adicción, pero no de la psicopatología concomitante.

b.- Se ofrece un abordaje terapéutico de la psicopatología concomitante, pero no de la adicción.

c.- Ambas opciones son falsas.

34.- El Servicio de Orientación Laboral diseña itinerarios orientados hacia:

a.- El autoempleo.

b.- El empleo protegido.

c.- Ambas opciones son correctas.

35.- El SAJIAD es un servicio de atención:

a.- A drogodependientes detenidos.

b.- A drogodependientes presos.

c.- A drogodependientes con enfermedades terminales.

36.- La atención a la demanda inicial en los CADs se realiza mediante (señala la opción incorrecta):

a.- La recepción.

b.- La acogida.

c.- El asesoramiento.

37.- Es una herramienta de gran utilidad en las primeras fases de la intervención:

a.- La inclusión en las entrevistas de la familia del paciente.

b.- La entrevista motivacional breve.

c.- Mantener en las entrevistas una carga emocional alta.

38.- El trabajador social colaborará:

a.- En la evaluación multidimensional.

b.- En el diseño del Plan Personalizado de Intervención (PPI).

c.- Ambas opciones son correctas.

39.- ¿Cuántos ejes se van a trabajar en el PPI?:

a.- 5 ejes.

b.- 6 ejes.

c.- 7 ejes.

40.- En el ámbito comunitario las trabajadoras sociales de los CAD:

a.- Podrán participar en los ETMFs y en las CAFs.

b.- Podrán trabajar en red con el tejido asociativo de los distritos.

c.- Ambas opciones son correctas.

41.- En el grupo de acogida para pacientes y familiares de los CAD se plantean como objetivos (señala la opción incorrecta):

a.- Reconvertir las demandas no ajustadas a la realidad.

b.- Facilitar la adherencia al tratamiento y minimizar los abandonos.

c.- Potenciar el acceso a recursos residenciales de tratamiento.

42.- Son perfiles de los participantes de los grupos terapéuticos con problemas de alcohol:

a.- Pacientes con abuso o dependencia del alcohol, aunque no se encuentren en situación de abstinencia.

b.- No padecer patología psiquiátrica que interfiera en el funcionamiento del grupo.

c.- Ambas opciones son correctas.

43.- Dentro de los CAD se van a desarrollar grupos específicos para pacientes con problemas de consumo de (señala la opción incorrecta):

a.- MDMA.

b.- THC.

c.- Cocaína.

44.- El grupo terapéutico para pacientes sin hogar se plantea:

a.- Lograr que los pacientes adquieran conocimientos básicos de educación para la salud.

b.- Lograr que los pacientes inicien procesos de mejora de su empleabilidad.

c.- Ambas opciones son correctas.

45.- El grupo terapéutico de familiares de adolescentes y jóvenes interviene con familiares de pacientes en tratamiento en el CAD:

a.- Menores de 30 años.

b.- Menores de 25 años.

c.- Menores de 20 años.

46.- Son objetivos del Protocolo de intervención desde el Trabajo Social en los CAD publicado en el año 2.012:

a.- Homogeneizar y ajustar las aportaciones que se realizan desde el área social al proceso de atención integral a las drogodependencias.

b.- Facilitar la tarea de las trabajadoras sociales, aportando diferentes metodologías y estrategias y recopilando experiencias de buenas prácticas en la intervención social.

c.- Ambas opciones son correctas.

47.- En el ámbito de las adicciones las siglas "PPI" hacen referencia a:

a.- Plan personalizado de intervención.

b.- Programa personalizado de intervención.

c.- Proyecto personalizado de intervención.

48.- El PPI debe ser consensuado:

a.- Siempre con el paciente.

b.- Siempre con la familia.

c.- Con el paciente y, a veces, con la familia.

49.- Dentro del eje 2 "Psicopatología" dentro del PPI no vamos a encontrar como objetivo específico:

a.- Prevenir y controlar las patologías asociadas e/o inducidas por el consumo de drogas para mejorar la calidad de vida.

b.- Reducir el nivel de ansiedad patológico.

c.- Minimizar el riesgo de suicidio.

50.- Son instrumentos de apoyo utilizados en el PPI dentro del eje familiar:

a.- El genograma.

b.- La visita a domicilio.

c.- Ambas opciones son correctas.

51.- Señala cual de las siguientes opciones corresponde a la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid:

a.- La Ley 5/2.000, de 27 de junio.

b.- La Ley 5/2.002, de 27 de junio.

c.- La Ley 5/2.005, de 27 de junio.

52.- Si hablamos del Centro "El Madroño" nos estamos refiriendo:

a.- Al Centro de Atención Básica Sociosanitaria.

b.- A la Unidad Móvil de Reducción del Daño.

c.- Al Programa de Mediación Comunitaria.

53.- Se realizan servicios de intercambio de jeringuillas, distribución de preservativos, papel de aluminio …:

a.- Desde la Unidad Móvil de Reducción del Daño.

b.- Desde el Centro de Atención Básica Sociosanitaria.

c.- Ambas opciones son correctas.

54.- A la Unidad Hospitalaria de desintoxicación de alcohol se accede:

a.- Desde los centros de primer y segundo nivel de la red.

b.- Exclusivamente desde los centros de segundo nivel de la red.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

55.- El tiempo de estancia en las Comunidades Terapéuticas es:

a.- De 3 meses.

b.- De 6 meses.

c.- De 12 meses.

56.- Son recursos convivenciales de apoyo al tratamiento y a la reinserción (señala la opción incorrecta):

a.- Las comunidades terapéuticas.

b.- Los recursos de auto gestión.

c.- Los recursos de apoyo al tratamiento para personas sin hogar.

57.- Dentro de la tipología de Pisos de Apoyo a la Reinserción podemos señalar:

a.- Los Pisos de apoyo a la desintoxicación.

b.- Los Pisos de patología dual.

c.- Ambas opciones son correctas.

58.- El tiempo de estancia de los pisos de reinserción de nivel básico es:

a.- De 12 meses.

b.- De 9 meses.

c.- De 6 meses.

59.- El tiempo de estancia de los pisos de reinserción de autogestión es:

a.- De 12 meses.

b.- De 9 meses.

c.- De 6 meses.

60.- Las Unidades de Farmacia ofrecerán la dispensación de:

a.- Sustitutivos de opiáceos.

b.- Sustitutivos del alcohol.

c.- Sustitutivos del cannabis.

Plantilla de respuestas

1.-	C, p. 3	**6.-**	C, p. 6	**11.-**	C, p. 7
2.-	C, p. 3	**7.-**	C, p. 6	**12.-**	A, p. 7
3.-	B, p. 4	**8.-**	C, p. 7	**13.-**	A, p. 8
4.-	C, p. 4	**9.-**	C, p. 7	**14.-**	A, p. 8
5.-	B, p. 6	**10.-**	C, p. 7	**15.-**	B, p. 8

16.-	C, p. 8	**21.-**	C, p. 10	**26.-**	C, p. 14
17.-	B, p. 9	**22.-**	A, p. 9	**27.-**	C, p. 14
18.-	C, p. 9	**23.-**	C, p. 12	**28.-**	A, p. 14
19.-	C, p. 10	**24.-**	B, p. 13	**29.-**	C, p. 14
20.-	C, p. 10	**25.-**	B, p. 13	**30.-**	C, p. 15

31.-	C, p. 15	**36.-**	C, p. 24	**41.-**	C, p. 32
32.-	A, p. 16	**37.-**	B, p. 24	**42.-**	B, p. 32
33.-	C, p. 16	**38.-**	C, p. 25	**43.-**	A, p. 33
34.-	C, p. 21	**39.-**	C, p. 26	**44.-**	A, p. 33
35.-	A, p. 22	**40.-**	C, p. 25	**45.-**	B, p. 35

46.-	C, p. 24	**51.-**	B, p. 6	**56.-**	A, p. 18
47.-	B, p. 25	**52.-**	B, p. 7	**57.-**	B, p. 19
48.-	C, p. 25	**53.-**	C, p. 10	**58.-**	B, p. 19
49.-	A, p. 26	**54.-**	B, p. 13	**59.-**	C, p. 19
50.-	C, p. 27	**55.-**	C, p. 16	**60.-**	A, p. 19